S A L U D P Ú B L I C A

Promoción de hábitos alimentarios saludables en la población adulta

Urbanización Britania, Cartagena de Indias, Bolívar

Integrantes

Camila Aguas Morales
Camila Benavides
Luis Fernando Bertel
David Carmona Rivero
Yorgeth Figueroa Hernández
Rosa Madrid Negrete
Karen Meléndez Rodriguez
Zharick Rodríguez Arbelaez

Nutrición y dietética

Docente:

Cartagena 28 octubre

Resumen

Este informe presenta el plan de intervención en salud pública "Promoción de hábitos alimentarios saludables en la población adulta", desarrollado en la Urbanización Britania (Cartagena, Bolívar). El problema priorizado fue la presencia de hábitos alimentarios poco saludables —consumo frecuente de comidas rápidas, ultraprocesados y bebidas azucaradas, junto con bajo consumo de frutas y verduras— que aumentan el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).

La línea base se construyó con una encuesta aplicada a 27 personas (63,0 % mujeres; 85,2 % entre 18 y 29 años; 59,3 % estudiantes). Se encontró que el 40,7 % no consumía fruta a diario, el 74,1 % consumía ninguna o una porción de verduras al día, el 88,9 % consumía ultraprocesados entre una y cuatro veces por semana y el 59,3 % consideraba no tener conocimientos suficientes sobre alimentación saludable. La falta de tiempo (40,7 %) y el precio de los alimentos saludables (29,6 %) fueron las principales barreras, y el 59,3 % manifestó que sí participaría en actividades comunitarias.

Con base en este diagnóstico se ejecutó una estrategia de prevención primaria basada en educación alimentaria y nutricional, y se definió un sistema de evaluación antes–después con metas SMART. Se discuten los resultados a la luz de los determinantes sociales de la salud y se proponen acciones de sostenibilidad.

Palabras clave: alimentación saludable, promoción de la salud, prevención primaria, enfermedades crónicas no transmisibles, determinantes sociales.

1. Diagnóstico y línea base

1.1 Título del proyecto

Promoción de hábitos alimentarios saludables en la población adulta de la Urbanización Britania, Cartagena, Bolívar.

1.2 Identificación del problema y urgencia de la intervención

Los malos hábitos alimentarios son un problema de salud pública porque son un factor de riesgo modificable de la malnutrición por exceso, la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir al menos 400 g de frutas y verduras al día (aproximadamente cinco porciones) como medida para prevenir las ECNT. A nivel nacional, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN 2015) reportó que más de la mitad de los adultos colombianos (56,4 %) tenía exceso de peso, lo que muestra la magnitud del problema.

En la población encuestada de la Urbanización Britania, los datos de línea base evidenciaron una distancia clara frente a esa recomendación: **solo 25,9 % consumía dos o más porciones de verduras al día y ninguna persona alcanzaba las tres porciones de fruta**. A esto se sumó el consumo regular de ultraprocesados, comidas rápidas y bebidas azucaradas. Por tratarse de una población joven, intervenir en esta etapa permite modificar hábitos antes de que se consoliden y aparezcan las enfermedades, lo que justificó la urgencia de la intervención.

1.3 Datos demográficos de la población atendida

La población estuvo conformada por 27 adultos de la Urbanización Britania que respondieron la encuesta de diagnóstico (formulario en línea). Sus características se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes (n = 27)

Variable	Categoría	n (%)
Sexo	Femenino	17 (63,0 %)
	Masculino	10 (37,0 %)
Edad	18–29 años	23 (85,2 %)
	40–49 años	2 (7,4 %)
	50–59 años	2 (7,4 %)
Nivel educativo	Universitario	13 (48,1 %)
	Secundaria	7 (25,9 %)
	Técnico/tecnológico	5 (18,5 %)
	Posgrado	2 (7,4 %)
Situación laboral	Estudiante	16 (59,3 %)
	Empleado(a)	6 (22,2 %)
	Otras (independiente, informal, desempleado, pensionado)	5 (18,5 %)
Estrato socioeconómico	Estrato 1	8 (29,6 %)
	Estrato 2	10 (37,0 %)
	Estrato 3	6 (22,2 %)
	Estrato 4	2 (7,4 %)
	Estrato 5	1 (3,7 %)
Ingreso mensual del hogar	Menos de 1 salario mínimo	9 (33,3 %)
	Entre 1 y 2 salarios mínimos	9 (33,3 %)
	Entre 2 y 3 salarios mínimos	6 (22,2 %)
	Prefirió no responder	3 (11,1 %)
Personas en el hogar	2–3 personas	16 (59,3 %)
	4–5 personas	9 (33,3 %)
	1 persona o 6 o más	2 (7,4 %)

Nota. Se encontró una población mayoritariamente joven, femenina, estudiante y de estratos 1 a 3 (88,8 %), con ingresos del hogar de hasta dos salarios mínimos en dos terceras partes de los casos (66,6 %).

1.4 Indicadores iniciales del problema de salud detectado

La Tabla 2 presenta los indicadores de línea base, que corresponden a la medición del "antes" de la intervención.

Tabla 2. Indicadores de línea base sobre hábitos alimentarios (n = 27)

Dimensión	Indicador	Resultado
Frutas	No consumía ninguna porción de fruta al día	11 (40,7 %)
	Consumía 1 porción al día	14 (51,9 %)
Verduras	Ninguna o 1 porción al día	20 (74,1 %)
	2 o más porciones al día	7 (25,9 %)
Ultraprocesados	Consumo de 1 a 4 veces por semana	24 (88,9 %)
	Consumo diario	2 (7,4 %)
Comidas rápidas	Consumo de 2 o más veces por semana	10 (37,0 %)
	Consumo de 1 vez por semana	12 (44,4 %)
Bebidas azucaradas	Consumo "algunas veces"	14 (51,9 %)
	Consumo frecuente	6 (22,2 %)
Comida fuera de casa	Comía fuera o compraba comida preparada 1–2 veces por semana	18 (66,7 %)
	3–4 veces por semana	5 (18,5 %)
Hidratación	Consumo de agua menor a 1,5 L/día	15 (55,5 %)
Tiempos de comida	Realizaba 3 tiempos de comida al día	17 (63,0 %)
Conocimientos	Consideraba no tener conocimientos suficientes	16 (59,3 %)
	Había recibido orientación alimentaria previa	14 (51,9 %)
Barreras	Falta de tiempo	11 (40,7 %)
	Precio de alimentos saludables	8 (29,6 %)
	Falta de conocimientos	5 (18,5 %)
Disposición	Participaría en actividades comunitarias	16 (59,3 %)
	Quizás participaría	8 (29,6 %)

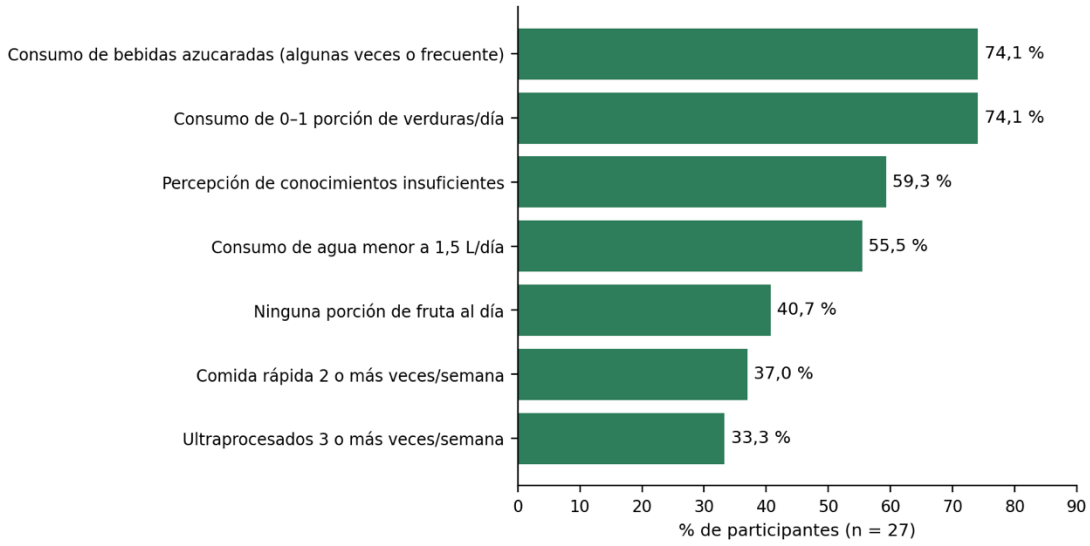


Figura 1. Principales factores de riesgo alimentario identificados en la línea base (n = 27).

2. Objetivos planteados

2.1 Objetivo general

Promover hábitos alimentarios saludables en la población adulta de la Urbanización Britania, Cartagena, mediante estrategias de educación alimentaria y nutricional que reduzcan los factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles.

2.2 Objetivos específicos (enfoque SMART)

Cada objetivo se redactó de forma específica, medible, alcanzable, relevante y con tiempo definido, y se vinculó directamente con la reducción de un riesgo o el aumento de conocimiento (Tabla 3).

Tabla 3. Objetivos específicos SMART

N.°	Objetivo específico	Indicador (línea base)	Meta
1	Aumentar el conocimiento sobre alimentación saludable, de modo que la proporción de participantes que se perciben sin conocimientos suficientes disminuya de 59,3 % a 30 % o menos al finalizar el ciclo de talleres.	Conocimientos insuficientes (59,3 %)	≤ 30 %
2	Aumentar el consumo de frutas y verduras, reduciendo a 20 % o menos la proporción de participantes que no consume fruta a diario y a 50 % o menos la que consume 0–1 porción de verduras al día, al finalizar el ciclo de talleres.	Sin fruta (40,7 %) 0–1 verdura (74,1 %)	≤ 20 % ≤ 50 %

N.°	Objetivo específico	Indicador (línea base)	Meta
3	Disminuir el consumo de bebidas azucaradas de 74,1 % a 50 % o menos (consumo ocasional o frecuente) y el de ultraprocesados de 3 o más veces por semana de 33,3 % a 20 % o menos, al finalizar la intervención.	Bebidas azucaradas (74,1 %) Ultraprocesados ≥3/sem (33,3 %)	≤ 50 % ≤ 20 %
4	Aumentar la ingesta de agua para que la proporción con consumo menor a 1,5 L/día pase de 55,5 % a 30 % o menos al finalizar la intervención.	Agua < 1,5 L (55,5 %)	≤ 30 %
5	Lograr que al menos 80 % de los participantes inscritos asista a mínimo dos de las tres sesiones educativas y elabore un menú saludable y económico.	Asistencia y menús elaborados (proceso)	≥ 80 %

3. Metodología ejecutada

3.1 Nivel de prevención aplicado

La intervención se ubicó en el **nivel de prevención primaria**, porque se dirigió a personas aparentemente sanas, con el fin de modificar factores de riesgo (alimentación inadecuada) antes de que aparezca la enfermedad. Su base fue la **promoción de la salud** mediante educación para la salud, en el marco de la Carta de Ottawa. Además, la encuesta de diagnóstico sirvió como acción de identificación de riesgos en la comunidad.

3.2 Crónica paso a paso del desarrollo de la actividad

1. **Identificación del problema y del lugar.** El grupo seleccionó los hábitos alimentarios poco saludables en adultos como problema de interés y la Urbanización Britania como lugar de intervención.
2. **Diseño y aplicación de la encuesta diagnóstica.** Se elaboró un cuestionario en formulario en línea con preguntas sociodemográficas, de frecuencia de consumo (frutas, verduras, ultraprocesados, comidas rápidas, bebidas azucaradas, agua), de tiempos de comida, barreras, conocimientos e interés en participar. Respondieron 27 personas.
3. **Análisis de resultados.** Los datos se tabularon y se presentaron en gráficos circulares y porcentajes, lo que permitió priorizar las necesidades: bajo consumo de frutas y verduras, falta de tiempo, costo de los alimentos y conocimientos insuficientes.
4. **Diseño del programa educativo.** A partir de los hallazgos se definieron las actividades, adaptadas a las costumbres, el presupuesto y la disponibilidad de alimentos de la población beneficiaria.
5. **Ejecución de las actividades educativas.** Se desarrollaron talleres de educación alimentaria y nutricional; elaboración de menús saludables y económicos; orientación sobre organización de horarios y preparación de comidas (respuesta a la barrera “falta de tiempo”); promoción del

consumo de frutas, verduras y agua; y estrategias para disminuir las bebidas azucaradas y los ultraprocesados.

6. **Evaluación y cierre.** Se previó aplicar nuevamente el cuestionario al finalizar para comparar la situación antes y después, y se formularon recomendaciones de continuidad.

3.3 Recursos y materiales de salud utilizados

Tabla 4. Recursos y materiales

Tipo de recurso	Descripción
Humanos	Ocho estudiantes integrantes del grupo (facilitadores, apoyo logístico y análisis de datos) y participantes de la comunidad.
Instrumentos	Cuestionario de hábitos alimentarios en formulario en línea; registro de asistencia.
Educativos	Presentación en Canva, material visual sobre porciones de frutas y verduras, y guías de menús saludables y económicos. Se tomaron como referencia las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la población colombiana.
Alimentos y demostración	Frutas, verduras y agua para las demostraciones de preparación de comidas saludables y económicas.
Tecnológicos	Teléfonos móviles y computadores para la encuesta, el análisis y la presentación de resultados.

4. Sistema de evaluación

4.1 Indicadores de proceso e impacto

Tabla 5. Indicadores seleccionados

Tipo	Indicador	Fórmula / meta
Proceso	Cobertura: personas que participaron en las actividades	(Participantes / personas convocadas) × 100. Meta ≥ 80 %
Proceso	Número de sesiones educativas ejecutadas	Sesiones realizadas / planeadas × 100. Meta 100 %
Proceso	Menús saludables y económicos elaborados por los participantes	Meta ≥ 80 % de los asistentes
Impacto	Proporción de participantes con conocimientos insuficientes	Antes 59,3 %. Meta ≤ 30 %
Impacto	Proporción sin consumo diario de fruta	Antes 40,7 %. Meta ≤ 20 %

Tipo	Indicador	Fórmula / meta
Impacto	Proporción con 0–1 porción de verduras al día	Antes 74,1 %. Meta ≤ 50 %
Impacto	Consumo de bebidas azucaradas y de ultraprocesados ≥3 veces/semana	Antes 74,1 % y 33,3 %. Meta ≤ 50 % y ≤ 20 %
Impacto	Proporción con consumo de agua < 1,5 L/día	Antes 55,5 %. Meta ≤ 30 %

4.2 Instrumentos aplicados y justificación

- **Cuestionario de hábitos alimentarios (antes y después):** se eligió porque permite medir de forma estandarizada y comparable la frecuencia de consumo y los conocimientos en poblaciones grandes con bajo costo. Al aplicar las mismas preguntas en ambos momentos, el cambio puede atribuirse con mayor objetividad a la intervención.
- **Preguntas de frecuencia de consumo por categorías:** reflejan los grupos de alimentos que la evidencia asocia con riesgo de ECNT (ultraprocesados, bebidas azucaradas) y con protección (frutas, verduras, agua).
- **Preguntas de barreras e interés:** permitieron adaptar las estrategias a la realidad económica y de tiempo de la comunidad.
- **Registro de asistencia:** sustenta los indicadores de proceso y de cobertura.

5. Resultados e impacto

5.1 Resultados de la línea base

La encuesta mostró que la mayoría de los participantes se alimentaba de forma distinta a lo recomendado. El 51,9 % consumía solo una porción de fruta al día y el 48,1 % una porción de verduras; el 88,9 % consumía ultraprocesados de 1 a 4 veces por semana; el 74,1 % consumía bebidas azucaradas al menos algunas veces; y el 55,5 % bebía menos de 1,5 L de agua al día. El 66,7 % comía fuera de casa o compraba comida preparada una o dos veces por semana, y el 63,0 % hacía tres tiempos de comida diarios.

Respecto a las barreras, la falta de tiempo fue la más mencionada (Figura 2), seguida del precio de los alimentos saludables; además, el 37,0 % indicó que el costo dificulta “algunas veces” su consumo y el 29,6

% que lo dificulta siempre.

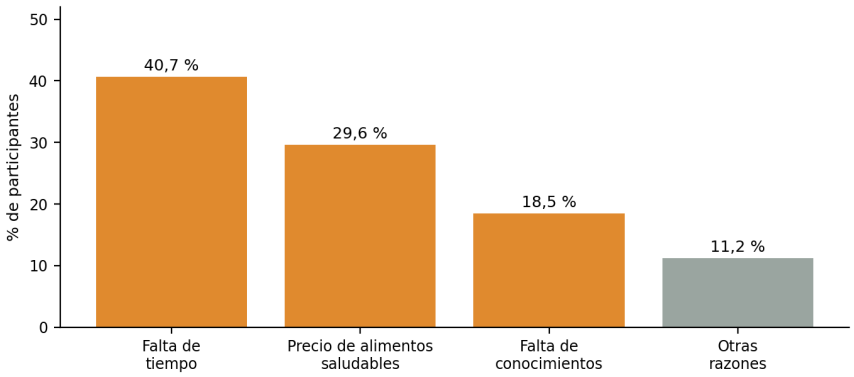


Figura 2. Principal dificultad para una alimentación saludable (n = 27).

5.2 Comparación directa: situación antes vs. después

La Tabla 6 y la Figura 3 comparan la línea base (antes) con las metas esperadas tras la intervención (después). Los valores del "antes" provienen de la encuesta aplicada; los del "después" corresponden a las metas definidas en los objetivos SMART, que se verificarán con la segunda aplicación del cuestionario.

Tabla 6. Situación antes vs. después y reducción esperada

Indicador	Antes (línea base)	Después (meta esperada)	Reducción esperada	Seguimiento
Sin consumo diario de fruta	40,7 %	≤ 20 %	20,7 pp	Por medir
0–1 porción de verduras/día	74,1 %	≤ 50 %	24,1 pp	Por medir
Bebidas azucaradas (algunas veces o frecuente)	74,1 %	≤ 50 %	24,1 pp	Por medir
Ultraprocesados ≥3 veces/semana	33,3 %	≤ 20 %	13,3 pp	Por medir
Agua < 1,5 L/día	55,5 %	≤ 30 %	25,5 pp	Por medir
Conocimientos insuficientes	59,3 %	≤ 30 %	29,3 pp	Por medir

pp = puntos porcentuales.

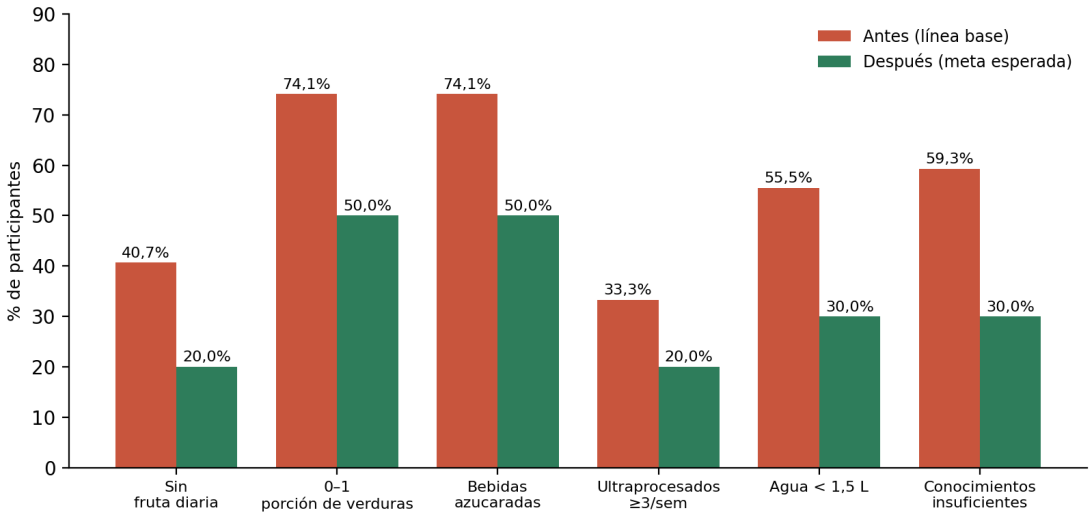


Figura 3. Comparación entre la línea base y las metas esperadas.

5.3 Porcentaje de cumplimiento de los objetivos

El cumplimiento de cada objetivo se calculará con la fórmula:

% de cumplimiento = (Valor antes − Valor después) / (Valor antes − Meta) × 100

Por ejemplo, si la proporción de participantes sin consumo diario de fruta bajara de 40,7 % a 25 %, el cumplimiento sería (40,7 − 25) / (40,7 − 20) × 100 = 75,8 %. Un valor igual o superior a 100 % indica que la meta fue alcanzada. Como la medición de seguimiento no se refleja en este informe, el porcentaje de cumplimiento queda definido metodológicamente y debe completarse con la segunda aplicación del cuestionario.

En cuanto al impacto ya observable, el principal resultado fue la identificación y priorización de las necesidades alimentarias de la comunidad y el alto interés de participación (88,9 % respondió “sí” o “tal vez”), condición favorable para el éxito de las actividades educativas.

6. Discusión y conclusiones

6.1 Lecciones aprendidas e imprevistos resueltos

- **Adaptar las actividades al tiempo disponible:** como la falta de tiempo fue la principal barrera (40,7 %), se incluyó orientación sobre organización de horarios y preparación rápida de comidas.
- **Considerar el presupuesto:** al ser el precio la segunda barrera (29,6 %), se propusieron menús saludables y económicos con alimentos accesibles.
- **Ajustar el mensaje a la población joven:** como predominaron adultos de 18 a 29 años, el material debió ser breve, práctico y visual.
- **Limitación de la muestra:** con 27 participantes, los resultados son descriptivos y no pueden generalizarse a toda la urbanización. Se recomienda ampliar la recolección de información entre los residentes de Britania.

6.2 Relación de los resultados con los determinantes sociales de la salud

Los hábitos alimentarios no dependen solo de la decisión individual: están condicionados por las condiciones en que las personas nacen, viven, estudian y trabajan. En este caso se identificaron:

- **Condiciones económicas:** el 66,6 % de los hogares tenía ingresos de hasta dos salarios mínimos y el 66,6 % de los participantes pertenecía a los estratos 1 y 2. Esto se relaciona con la percepción de que los alimentos saludables son costosos (66,6 % dijo que el precio los dificulta siempre o algunas veces).
- **Educación:** el 59,3 % reconoció no tener conocimientos suficientes, aunque el 51,9 % ya había recibido orientación, lo que sugiere que la información aislada no basta y requiere acompañamiento práctico.
- **Tiempo y condiciones de vida:** la carga académica y laboral, propia de una población mayoritariamente estudiante, limita la preparación de alimentos en casa y favorece las comidas rápidas y preparadas.
- **Entorno alimentario y acceso:** la oferta de comida rápida y ultraprocesados, generalmente más barata y de fácil acceso, compite con las frutas y verduras.

Estas barreras del entorno (pobreza, educación y acceso) afectaron el alcance potencial del proyecto, por lo que el cambio de hábitos exige estrategias que combinen educación con alternativas económicamente viables.

6.3 Propuestas de sostenibilidad en el tiempo

- Formar **promotores o líderes comunitarios** voluntarios que continúen los talleres de alimentación saludable.
- Articular acciones con la **Junta de Acción Comunal**, instituciones educativas y el centro de salud más cercano.
- Crear **huertas o mercados de alimentos frescos** comunitarios y grupos de compra colectiva para reducir el costo de frutas y verduras.
- Distribuir material educativo breve (recetarios económicos, planificadores semanales de comidas) por redes sociales y grupos de mensajería.
- Repetir la medición de indicadores cada seis meses para monitorear los cambios y ajustar las estrategias.

6.4 Conclusiones

El diagnóstico realizado en la Urbanización Britania confirmó que intervenir era necesario y oportuno. La mayoría de los participantes, jóvenes en su mayor parte, se alejaba de una alimentación equilibrada: el 74,1 % consumía ninguna o una porción de verduras al día, el 40,7 % no consumía fruta a diario y casi 9 de cada 10 consumían ultraprocesados con regularidad. Esta combinación de factores de riesgo justificó una estrategia de prevención primaria, orientada a modificar los hábitos antes de que aparezcan las enfermedades crónicas no transmisibles.

El estudio también mostró que el problema no se explica solo por falta de información. La escasez de

tiempo, el costo de los alimentos saludables y los vacíos de conocimiento, en un contexto de ingresos limitados y estratos bajos, evidenciaron el peso de los determinantes sociales sobre la alimentación. Por eso, las acciones educativas debieron ser prácticas, económicas y ajustadas a la rutina de la comunidad, y no limitarse a transmitir mensajes generales.

Finalmente, el interés de casi 9 de cada 10 participantes en involucrarse en actividades comunitarias (88,9 %) representa la mayor fortaleza del proyecto y una base real para su continuidad. El sistema de evaluación antes–después, con indicadores de proceso e impacto y metas SMART, deja establecida la forma de medir objetivamente el cambio y el cumplimiento de los objetivos. Se recomienda ampliar la muestra y sostener la intervención con apoyo de líderes comunitarios e instituciones locales, de modo que los hábitos saludables se mantengan en el tiempo.

Referencias

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). Guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor de 2 años. Bogotá, Colombia.

Ministerio de Salud y Protección Social, ICBF et al. (2019). Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia 2015 (ENSIN 2015). Bogotá, Colombia.

Organización Mundial de la Salud. (2020). Alimentación sana [Nota descriptiva]. OMS.

Organización Mundial de la Salud. (1986). Carta de Ottawa para la promoción de la salud. Ottawa, Canadá.

Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. (2009). Subsanar las desigualdades en una generación. OMS.

Fuente de los datos de línea base: encuesta propia aplicada por el grupo en la Urbanización Britania (n = 27).